



ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

journal homepage: <http://www.elsevier.com/locate/kontakt>

Original research article

Pohlavie, vek a proaktívne zvládanie ako prediktory zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny

Gender, age and proactive coping as predictors of coping in patients with limb amputation

Andrea Solgajová ^{a*}, Tomáš Sollár ^b, Gabriela Vörösová ^a

^a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva, Slovenská republika

^b Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie, Slovenská republika

INFORMACE O ČLÁNKU

Received: 2014-10-05

Received in revised form:

2014-11-11

Accepted: 2015-01-19

Published online: 2015-06-19

Keywords:

Stress

Coping

Load

Amputation

Nursing Outcomes Classification system

ABSTRACT

Patients with indications of amputation experience stressful situations of high intensity as several stressors combine, including particularly the surgical procedure, pain, immobilisation, hospitalisation, and concerns about future. The intensity of the stressful situation can be so high that patients do not have the ability to cope with it. In such situations, the nursing diagnosis “Ineffective Coping” (00069) is given to patients, which requires an intervention. In clinical decision making, nurses should take various predisposing factors into consideration regarding patient care to predict the development of coping. The research objective was to study the effects of gender, age and proactive coping strategies on the effectiveness of coping in patients with lower limb amputation. The research included 50 respondents (25 women and 25 men) with the indicated amputation of a lower limb. We used the NOC (Nursing Outcomes Classification) scale – Coping (1302) to assess the effectiveness of coping, and the PCI (Proactive Coping Inventory) to assess proactive coping. The software SPSS 22.0 was used for statistical data analysis. The gender and age do not prove to be statistically significant predictors of coping in patients with lower limb amputation. Three proactive coping strategies are suggested as significant predictors of effective coping (Preventive Coping, Avoidance Coping, and Strategic Planning). Knowing the preferred coping strategies in patients can be beneficial for nurses as it is the main predictor of coping with amputation in patients.

S Ú H R N

Pacient s indikáciou amputácie sa dostáva do stresovej situácie, ktorá má veľkú intenzitu z dôvodu kumulácie viacerých stresorov, ktorými sú najmä chirurgický zákrok, bolesť, imobilizácia, hospitalizácia, obavy z budúcnosti. Intenzita stresovej situácie môže byť taká silná, že pacient nemá schopnosť, resp. možnosť sa s ňou vyrovnáť. V tejto situácii sa pacientovi diagnostikuje ošetrovateľská diagnóza Neefektívne zvládanie záťaže (00069), ktorá si vyžaduje riešenie. Pre sestru je potrebné v klinickom rozhodovaní zvažovať rôzne predispozičné faktory pacienta, aby mohla predikovať

Kľúčové slová:

stres

zvládanie

záťaž

amputácia

klasifikačný systém výsledkov ošetrovateľstva

* **Korespondenční autor:** PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva, Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra, Slovenská republika; e-mail: asolgajova@ukf.sk
<http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2015.01.005>

KONTAKT XVII/2: 79–85 • ISSN 1212-4117 (Print) • ISSN 1804-7122 (Online)

vývoj zvládania záťaže. Cieľom výskumu bolo skúmať vplyv pohlavia, veku a stratégií proaktívneho zvládania na efektivitu zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny. Výskumu sa celkovo zúčastnilo 50 respondentov (25 žien a 25 mužov), ktorým bola indikovaná plánovaná amputácia dolnej končatiny. Pre hodnotenie efektivity zvládania záťaže sme použili škálu NOC (Nursing Outcomes Classification) – Zvládanie záťaže (1302) a pre hodnotenie proaktívneho zvládania dotazník PCI (Proactive Coping Inventory). Na štatistické spracovanie výsledkov sme použili softvér SPSS 22.0. Pohlavie a vek sa neukazujú ako štatisticky významné prediktory zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny. Tri stratégie proaktívneho zvládania sa javia ako významné prediktory efektívneho zvládania záťaže (Preventívne zvládanie, Vyhybanie sa riešeniu situácií a stratégia Strategické plánovanie). Znalosť bežnej stratégie zvládania záťaže pacientom môže byť pre sestru prínosná, nakoľko ide o hlavný prediktor toho, ako bude pacient zvládať amputáciu.

© 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.
Published by Elsevier Urban & Partner Sp. z o. o. All rights reserved.

Úvod

V súčasnosti sa v literatúre popisujú pojmy záťaž a stres vo vzťahu k zvládaniu ako pojmy podobného významu, ale odborná literatúra poukazuje na ich nezlučiteľnosť a dôležitosť ich odlišovania. Pojem záťaž je charakterizovaný ako súbor požiadaviek vonkajšieho alebo vnútorného prostredia, ktorým je človek schopný vyhovieť, čo znamená, že sa dokáže s nimi vyrovnáť. Stres je charakterizovaný ako súbor požiadaviek kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru, na ktoré človek nie je schopný reagovať pozitívne, tzn. vyrovnáť sa s ním [1]. V súvislosti s pôsobením stresu sa stresová situácia charakterizuje ako stav, kde je miera intenzity stresovej situácie vyššia ako možnosť, resp. schopnosť človeka danú situáciu zvládnuť [2].

Stresory, teda činitele vonkajšieho prostredia, ktoré môžu vyvolať v organizme stav stresu, rozdeľuje Schreiber [3] do kategórií, ktoré sú vyhovujúce aj pre medicínsku prax. Napríklad chirurgický zákrok, bolesť a imobilizáciu charakterizuje ako somatický patologický stresor a medzi psychologické stresory zaraďuje stresory z choroby (bolesti, starosti, imobilizácia, hospitalizácia).

Pojmu zvládanie záťaže sa venuje pozornosť aj v oblasti ošetrovateľskej praxe už niekoľko rokov a v rôznych situáciách, pričom v rámci klasifikačného systému NANDA International (NANDA I) vznikli v súvislosti s týmto pojmom viaceré ošetrovateľské diagnózy. Vo výskume bližšie rozoberáme ošetrovateľskú diagnózu Neefektívne zvládanie záťaže (00069), ktorú Herdman [4] a Ackley a Ladwig [5] charakterizujú ako „neschopnosť správne vyhodnocovať stresory, nesprávny výber reakcií, a/alebo neschopnosť využívať dostupné zdroje“. K definícii ošetrovateľskej diagnózy sú uvedené aj definujúce charakteristiky a súvisiace faktory [4,5]. Pre objektivizáciu vývoja tejto diagnózy u pacienta bolo v rámci Nursing Outcomes Classification (NOC) vytvorených niekoľko škál, napríklad Rozhodovanie (0906), Úroveň stresu (1212), Akceptácia: zdravotný stav (1300), Zvládanie záťaže (1302), Psychosociálna adaptácia: životná zmena (1305), Adaptácia na fyzické postihnutie (1308), Osobná odolnosť (1309) a iné [5].

Všeobecne môžeme charakterizovať zvládanie záťaže ako súbor kognitívnych a behaviorálnych snažení človeka

zvládnuť podmienky, ktoré presahujú mieru jeho momentálnych adaptačných schopností, teda ohrozujú alebo prevyšujú jeho zdroje [6]. V rámci výskumu sa zameriavame najmä na zvládacie vzorce (stratégie), ktoré sú charakterizované ako návykové, transsituačné, relatívne konzistentné vzorce spracovania a zvládania na behaviorálnej, kognitívnej alebo zážitkovej úrovni, ktoré človek používa pri stretávaní sa s internými alebo externými stresormi [7]. Predstavujú všeobecné vzorce správania sa človeka v rôznych typoch záťažových situácií.

Lazarus a Folkman [6] popisujú dve formy stratégií zvládania záťaže: zvládanie zamerané na problém (človek sa zameriava na situáciu, pričom má [konštruktívnu] snahu hľadať spôsoby, ako ju zmeniť, prípadne sa jej v budúcnosti vyhnúť) a zvládanie orientované na emócie (kedy sa človek zameriava na zmiernenie prežívaných emócií, ktoré vznikli v dôsledku stresu, pričom k zmene situácie nemusí dôjsť). Túto teóriu doplnili Schwarzer a Taubert [8] o časový aspekt, čo formulovali v koncepcii proaktívneho zvládania záťaže. Podstata tohto prístupu spočíva v anticipácii pôsobenia stresora a riešenia situácie pred nástupom a rozvojom stresovej situácie. Cieľom koncepcie bolo vytvoriť pozitívne orientovaný spôsob zvládania záťaže, vychádzajúci zo stanovenia cieľov a usilovanie sa o ich zvládnutie ešte pred plným nástupom vplyvu stresora [9].

Analýzou odbornej literatúry môžeme konštatovať, že zvládanie záťaže môže byť ovplyvňované mnohými premennými, ako je napríklad osobnosť [10, 11, 12], pohlavie [6], a vek [13]. Ruiselová [14] uvádza, že po rokoch intenzívneho skúmania zvládania záťaže sa zdôrazňujú najmä situačné vplyvy a vplyvy dispozičné, ako aj ich vzájomná interakcia.

Cieľom výskumu bolo skúmať vplyv pohlavia, veku a stratégií proaktívneho zvládania na efektivitu zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny.

Metodika a charakteristika súboru

Výskumu sa celkovo zúčastnilo 50 respondentov z oddelenia cievnej chirurgie Fakultnej nemocnice v Nitre. Zaraďujúcimi kritériami respondentov do výberového súboru bola

indikovaná plánovaná amputácia dolnej končatiny z dôvodu nedostatočného prekrvenia končatiny pri diabetes mellitus a arterioskleróze, maximálne 7. deň po amputácii, informovaný súhlas pacienta a ochota pacienta podieľať sa na výskume. Z celkového počtu 50 respondentov bolo 25 žien a 25 mužov. Priemerný vek respondentov bol 66,14 (SD = 16,08; min. = 23; max. = 89), do 65 rokov 49 % respondentov.

Vzhľadom na stanovené ciele a hypotézy výskumu sme použili škálu z klasifikačného systému NOC – Zvládanie záťaže (1302) [15], odporúčanú pre hodnotenie ošetrovateľskej diagnózy Neefektívne zvládanie záťaže (00069). Pre použitie vo výskume bola pôvodná anglická verzia škály preložená dvomi nezávislými prekladateľmi, následne prešla jazykovou korektúrou a bola prispôbená pre použitie v našich podmienkach odborníkmi z ošetrovateľstva a psychológie. Škála obsahuje 17 položiek hodnotených na Likertovej škále od 1 do 5 (1 – nikdy nepreukazovaný, 2 – ojedinele preukazovaný, 3 – niekedy preukazovaný, 4 – často preukazovaný a 5 – neustále preukazovaný). Hodnotia sa všetky prejavy samostatne a zvlášť sumárne skóre.

Pre hodnotenie proaktívneho zvládania sme použili Greenglassovej dotazník PCI (Proactive Coping Inventory), pričom sme použili slovenskú verziu [16]. Dotazník obsahuje 7 subškál: Proaktívne zvládanie (14 položiek), Reflektívne zvládanie (11 položiek), Strategické plánovanie (4 položky), Preventívne zvládanie (10 položiek), Vyhľadávanie inštrumentálnej opory (8 položiek), Vyhľadávanie emočnej opory (5 položiek) a Vyhýbanie sa riešeniu situácie (3 položky). Položky sú hodnotené na štvorbodovej škále (vôbec nie je pravda, takmer nie je pravda, trochu pravda, úplná pravda). Presvedčenia jednotlivcov s vysokým skóre v škálach proaktívneho zvládania obsahujú bohatý potenciál pre zmenu, ktorá vyúsťuje do zlepšenia seba samého a svojho okolia. Výskum bol schválený Etickou komisiou Fakultnej nemocnice v Nitre. Zber dát bol realizovaný sestrou z oddelenia cievnej chirurgie Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorá bola pre použitie oboch meracích nástrojov zaškolená.

Na štatistické spracovanie výsledkov sme použili softvér SPSS 22.0. Na určovanie úrovne zvládania záťaže sme použili aritmetický priemer a štandardnú odchýlku. Na testovanie rozdielu dvoch skupín (porovnanie podľa pohlavia a podľa veku) sme použili Studentov t-test pre dva nezávislé výbery. Na skúmanie vzťahu stratégií zvládania záťaže a situačného zvládania záťaže sme použili viacnásobnú lineárnu regresnú analýzu, krokovú metódu.

Výsledky

Výsledky odpovedajú na tri otázky ohľadom skúmania prediktorov zvládania záťaže pacientov po amputácii dolnej končatiny. V prvej časti analyzujeme rozdiely medzi mužmi a ženami vo zvládaní záťaže, v druhej časti skúmame vzťah veku a zvládania záťaže. V tretej časti skúmame vzťah prediktorov proaktívneho zvládania (preferovanej stratégie prístupu k stresujúcim situáciám) k samotnému zvládaniu pacientov po amputácii.

Na základe sumárneho skóre položiek hodnotiacich zvládanie záťaže (NOC – Zvládanie záťaže 1302) nemôže-

me celkovú úroveň zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny hodnotiť ani ako výrazne efektívnu, ani výrazne neefektívnu ($M_{\min} = 2,00$, $M_{\max} = 4,06$). Z položiek zvládania záťaže sa ako najviac efektívne ukazujú položky: Verbalizuje akceptáciu situácie ($M = 3,78$), Prispôsobuje sa životným zmenám ($M = 3,88$), Vyhýba sa príliš stresujúcim situáciám ($M = 3,92$). Ako najviac neefektívne položky zvládania záťaže u pacientov s amputáciou dolných končatín sú: Používa efektívne stratégie zvládania ($M = 2,66$), Udáva pokles vo fyzických symptómoch stresu ($M = 2,78$), Obstaráva si asistenciu od zdravotníka ($M = 2,80$), Modifikuje životný štýl ($M = 2,86$), Používa správanie na redukciu stresu ($M = 2,92$), Udáva pokles v negatívnych pocitoch ($M = 2,96$).

Pohlavie ako prediktor zvládania záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny

V tejto časti výsledkov uvádzame porovnanie zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny podľa pohlavia v jednotlivých sedemnástich hodnotených položkách a v sumárnom skóre (tab. 1).

Zistili sme, že muži a ženy po amputácii dolnej končatiny sa štatisticky významne nelíšia v zvládaní záťaže ani v jednotlivých položkách, ani v sumárnom skóre ($p = ns.$). Interpretáciu uvedeného výsledku uvádzame nižšie. Pohlavie sa neukazuje ako významný prediktor efektívneho/neefektívneho zvládania záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny.

Vek ako prediktor zvládania záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny

V tejto časti výsledkov uvádzame porovnanie dvoch vekových skupín pacientov s amputáciou dolnej končatiny (do 65 rokov a nad 65 rokov) v jednotlivých sedemnástich hodnotených položkách zvládania záťaže a v sumárnom skóre (tab. 2).

Zistili sme, že pacienti s amputáciou dolnej končatiny do 65 rokov a nad 65 rokov sa štatisticky významne nelíšia v zvládaní záťaže ani v jednotlivých položkách, ani v sumárnom skóre ($p = ns.$). Vek sa neukazuje ako významný prediktor efektívneho/neefektívneho zvládania záťaže.

Proaktívne zvládanie (stratégie) ako prediktor (situačného) zvládania záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny

V tretej časti výsledkov skúmame vzťah stratégií zvládania záťaže (v rámci koncepcie proaktívneho zvládania) [8, 9] k samotnému zvládaniu záťaže posudzovaného sestrou. Nakoľko sa v predošlých analýzach neukazujú štatisticky významné rozdiely na úrovni jednotlivých položiek, v tejto časti pracujeme iba so sumárnym skóre. Na vyhodnotenie výsledkov sme použili viacnásobnú lineárnu regresnú analýzu (krokovú metódu), ktorá štatistickým spôsobom eliminuje štatisticky nevýznamné prediktory (z pôvodného počtu sedem stratégií proaktívneho zvládania) závislej premennej (aktuálne zvládanie záťaže pacienta). Výsledky naznačujú tri modely, ktoré predikujú zvládanie záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny.

Tabuľka 1 – Porovnanie pacientov s amputáciou dolnej končatiny vo zvládaní záťaže podľa pohlavia

	Muži (<i>n</i> = 25)		Ženy (<i>n</i> = 25)		<i>t</i>	df	<i>p</i>
	<i>M</i> ₁	<i>SD</i> ₁	<i>M</i> ₂	<i>SD</i> ₂			
Verbalizuje pocit kontroly	2,96	0,84	3,44	1,00	1,83	48	0,072
Udáva pokles stresu	3,00	0,82	3,08	0,91	0,33	48	0,744
Verbalizuje akceptáciu situácie	3,68	0,69	3,88	0,97	0,84	48	0,405
Vyhľadáva renomované informácie o diagnóze	2,88	1,09	3,32	0,90	1,55	48	0,126
Vyhľadáva renomované informácie o liečbe	3,04	1,14	3,32	1,18	0,85	48	0,396
Modifikuje životný štýl na redukciu stresu	2,84	0,94	2,88	0,88	0,15	48	0,877
Prispôsobuje sa životným zmenám	3,84	1,03	3,92	0,86	0,30	48	0,766
Používa osobný podporný systém	2,84	1,37	3,40	1,32	1,47	48	0,148
Používa správanie na redukciu stresu	2,92	0,91	2,92	1,04	0,00	48	1,00
Identifikuje rôzne stratégie zvládania	2,96	1,31	3,16	1,21	0,56	48	0,577
Používa efektívne stratégie zvládania	2,56	1,19	2,76	1,05	0,63	48	0,532
Vyhýba sa príliš stresujúcim situáciám	3,64	1,41	4,20	0,91	1,67	48	0,102
Verbalizuje potrebu asistencie	3,40	1,41	3,32	1,25	0,21	48	0,833
Obstará si asistenciu od zdravotníka	2,76	1,33	2,84	1,34	0,21	48	0,833
Udáva pokles vo fyzických symptómoch stresu	2,80	0,87	2,76	0,97	0,15	48	0,878
Udáva pokles v negatívnych pocitoch	3,08	0,81	2,84	0,94	0,96	48	0,339
Udáva zlepšenie psychologickej pohody	3,20	0,76	3,16	1,11	0,15	48	0,882
Zvládanie záťaže – sumárne skóre	3,08	0,58	3,24	0,51	1,05	48	0,295

Tabuľka 2 – Porovnanie pacientov s amputáciou dolnej končatiny vo zvládaní záťaže podľa veku

	Do 65 rokov (<i>n</i> = 25)		Nad 65 rokov (<i>n</i> = 25)		<i>t</i>	df	<i>p</i>
	<i>M</i> ₁	<i>SD</i> ₁	<i>M</i> ₂	<i>SD</i> ₂			
Verbalizuje pocit kontroly	3,36	0,95	3,04	0,93	1,20	48	0,236
Udáva pokles stresu	3,24	0,72	2,84	0,94	1,68	48	0,099
Verbalizuje akceptáciu situácie	3,84	0,99	3,72	0,68	0,50	48	0,618
Vyhľadáva renomované informácie o diagnóze	3,04	0,89	3,16	1,14	0,41	48	0,680
Vyhľadáva renomované informácie o liečbe	3,24	1,16	3,12	1,17	0,36	48	0,717
Modifikuje životný štýl na redukciu stresu	2,88	0,83	2,84	0,99	0,15	48	0,877
Prispôsobuje sa životným zmenám	4,04	0,73	3,72	1,10	1,21	48	0,232
Používa osobný podporný systém	3,40	1,19	2,84	1,49	1,47	48	0,148
Používa správanie na redukciu stresu	2,80	0,87	3,04	1,06	0,88	48	0,384
Identifikuje rôzne stratégie zvládania	3,32	1,11	2,80	1,35	1,49	48	0,143
Používa efektívne stratégie zvládania	2,96	0,93	2,36	1,22	1,95	48	0,056
Vyhýba sa príliš stresujúcim situáciám	3,76	1,27	4,08	1,15	0,93	48	0,354
Verbalizuje potrebu asistencie	3,20	1,19	3,52	1,45	0,85	48	0,397
Obstará si asistenciu od zdravotníka	2,76	1,23	2,84	1,43	0,21	48	0,833
Udáva pokles vo fyzických symptómoch stresu	2,76	0,83	2,80	1,00	0,15	48	0,878
Udáva pokles v negatívnych pocitoch	2,92	0,91	3,00	0,87	0,32	48	0,751
Udáva zlepšenie psychologickej pohody	3,32	1,03	3,04	0,84	1,05	48	0,297
Zvládanie záťaže – sumárne skóre	3,22	0,55	3,10	0,57	0,78	48	0,438

Tabuľka 3 prezentuje celkové zhodnotenie troch modelov predikujúcich zvládanie záťaže. Prvý model určuje najsilnejší prediktor spomedzi stratégií proaktívneho zvládania, ktorým je Preventívne zvládanie situácií. Tento model vysvetľuje 25 % variability rozptylu závislej premennej ($R^2 = 0,253$). Druhý model obsahuje okrem premennej Preventívne zvládanie situácií aj stratégiu Vyhýbanie sa riešeniu situácií. Tento model vysvetľuje 32 % variability závislej premennej ($R^2 = 0,324$), pričom lepšie zvládanie vykazujú pacienti s preferenciou Preventívneho zvládania situácií a Nevyhýbania sa riešeniu situácií (negatívna hodnota regresného koeficientu v tab. 4). Ako štatisticky významný sa ukazuje ešte jeden model obohatený o pre-

mennú Strategické plánovanie (model 3 vysvetľuje takmer 39 % variability zvládania záťaže; $R^2 = 0,387$). Ostatné premenné (Proaktívne zvládanie, Reflektívne zvládanie, Vyhľadávanie inštrumentálnej opory a Vyhľadávanie emočnej opory) neprispievajú k vysvetleniu situačného zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny štatisticky významne (sú z modelov štatisticky eliminované). Znamená to teda, že efektívne zvládanie záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny najviac predpovedajú premenné Preventívne zvládanie situácií, Ne/vyhýbanie sa riešeniu situácií a Strategické plánovanie. Interpretáciu týchto výsledkov uvádzame nižšie v diskusii.

Tabuľka 3 – Celkové zhodnotenie modelu predikcie zvládania záťaže stratégiami proaktívneho zvládania u pacientov s amputáciou dolnej končatiny

	<i>R</i>	Adj <i>R</i> ²	<i>F</i>	<i>p</i>
Model 1 (Preventívne zvládanie)	0,518	0,253	17,562	<0,001
Model 2 (Preventívne zvládanie, Vyhýbanie)	0,593	0,324	12,735	<0,001
Model 3 (Preventívne zvládanie, Vyhýbanie, Strategické plánovanie)	0,652	0,387	11,325	<0,001

Tabuľka 4 – Regresné koeficienty prediktorov troch modelov predikcie zvládania záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny

		<i>B</i>	SE(<i>B</i>)	β	<i>t</i>	<i>p</i>
Model 1	Preventívne zvládanie situácií	0,889	0,212	0,518	4,191	<0,001
Model 2	Preventívne zvládanie situácií	0,776	0,207	0,452	3,748	<0,001
	Vyhýbanie sa riešeniu situácie	-1,166	0,474	-0,297	-2,461	0,018
Model 3	Preventívne zvládanie situácií	0,493	0,229	0,287	2,153	0,037
	Vyhýbanie sa riešeniu situácie	-1,519	0,474	-0,386	-3,205	0,002
	Strategické plánovanie	1,341	0,554	0,319	2,422	0,019

Pozn.: *B* – neštandardizovaný regresný koeficient; SE(*B*) – štandardná chyba neštandardizovaného regresného koeficientu; β – štandardizovaný regresný koeficient.

Zhrnutie výsledkov

Pohlavie a vek sa neukazujú ako štatisticky významné prediktory zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny. Na druhej strane tri stratégie z koncepcie proaktívneho zvládania (Preventívne zvládanie, Vyhýbanie sa riešeniu situácií a Strategické plánovanie) sa javia ako významné prediktory efektívneho zvládania záťaže. Úroveň zvládania záťaže poukazuje na mierny až stredný stupeň určitých problémov pri zvládaní záťaže pacientov tejto skupiny, čo je do istej miery adekvátne kontextu situácie, v ktorej sa nachádzajú, ako diskutujeme v nasledujúcej časti.

Diskusia

Vo výskume sa zaoberáme skúmaním efektivity zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny v krátkom

časovom odstupe od operácie (do 7 dní) a jeho možnými prediktormi (vek, pohlavie a stratégie zvládania záťaže).

Výskumy zvládania záťaže u pacientov s amputáciami sú zamerané častejšie na skúmanie stratégií zvládania záťaže ako na samotné zvládanie [17]. Amputáciu môžeme definovať ako kombináciu somatického a psychologického stresoru [3]. Vzájomným pôsobením chirurgického zákroku, bolesti, imobilizácie, hospitalizácie a obáv z budúcnosti u pacienta sa intenzita stresovej situácie znásobuje a, ako uvádza Křivohlavý [2], človek nemusí danú situáciu zvládnuť.

Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že pacienti s amputáciou dolnej končatiny nevykazujú výrazne neefektívne zvládanie, ale ani výrazne efektívne, čo je pre danú situáciu celkom prirodzené. To, že sa u pacientov s amputáciou dolnej končatiny nevyskytuje výrazne neefektívne zvládanie záťaže, môže súvisieť aj s konštatovaním Hampele et al. [18], ktorí uvádzajú, že pacienti s chronickým ochorením sa dostávajú viac do špecifických situácií, čo môže

viest k efektívnejším stratégiám zvládania každodenných stresových faktorov. Pacienti s amputáciou dolnej končatiny patria do skupiny pacientov s chronickým ochorením, dokonca samotná amputácia je mnohokrát už dôsledkom ich chronického ochorenia (diabetes mellitus, ateroskleróza). Zároveň je spravidla pacient o možnej amputácii ako o dôsledku svojho chronického ochorenia informovaný niekoľko mesiacov pred jej vykonaním, čím má dostatok času sa na danú situáciu pripraviť. Tým sa dá vysvetliť zistený výsledok o efektívnejšom zvládaní záťaže pacientmi v položkách: verbalizovanie akceptácie situácie pacientom; prispôsobuje sa zmenám; vyhýbanie sa príliš stresujúcim situáciám. Naše zistenie podporujú aj uvedenia, že výskyt posttraumatickej stresovej poruchy u pacientov má vyššiu prevalenciu u traumatických (neplánovaných) amputácií ako u plánovaných chirurgických amputácií v dôsledku chronických chorôb. Súvisí to nielen s možnosťou pripraviť sa na danú situáciu, ale aj s prítomnosťou emocionálneho stresu v súvislosti s úrazom [19].

V nasledovných položkách: udáva pokles vo fyzických symptómoch stresu, používa efektívne stratégie zvládania záťaže, modifikuje svoj životný štýl a udáva pokles v negatívnych pocitoch, pacienti vykazovali menej efektívne zvládanie záťaže. Niektoré z týchto položiek boli hodnotené ako viac nepreukazované u pacientov možno aj z dôvodu krátkeho časového odstupu od operácie ako aj toho, že neboli v domácom prostredí, ale ešte hospitalizovaní.

Lazarus, Folkman [6] a Výrost et al. [20] popisujú rozdiely vo zvládaní záťaže u mužov a žien. Podľa našich zistení sa pohlavie neukazuje ako významný prediktor efektívneho/neefektívneho zvládania záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny. Rozdiely vo zvládaní záťaže u mužov a žien nie sú explicitne vnímané ani pri bežnej záťaži každodenných stresorov, ale ani v iných situáciách, kedy je predpoklad intenzívnejšieho pôsobenia stresorov, napríklad pri amputácii.

Keefe a Williams [13] zistili, že nie je rozdiel medzi viacerými vekovými skupinami pacientov s chronickou bolesťou v stratégiách zvládania záťaže. Výsledky nášho výskumu podporujú tieto zistenia, že vek sa neukazuje ako významný prediktor efektívneho/neefektívneho zvládania záťaže, rovnako ako pohlavie. Záverom môžeme konštatovať, že samotná intenzita stresovej situácie dokáže ovplyvniť schopnosti človeka viac ako vek či pohlavie.

Typická stresová situácia, ktorá nastáva vplyvom pôsobenia každodenných stresorov, vytvára u človeka stratégie, akými sa človek snaží vyrovnáť sa s nimi, zvládnuť ich. Zaujímalo nás, či bežné stratégie zvládania človeka vplyvajú na efektivitu zvládania záťaže aj v inej (ťažšej) situácii, ako je napríklad amputácia, kde je predpoklad pôsobenia vyššej intenzity stresorov. Stratégie zvládania záťaže sú dôležité prediktory psychologickej adaptácie u pacientov s amputáciami [21, 22]. Na základe zistení Greenglassovej et al. [23, 24] sa domnievame, že ak človek využíva pri zvládaní každodenných stresorov určité stratégie zvládania, tak je vysoký predpoklad efektívneho zvládnutia záťaže aj vyššej intenzity, akou je napríklad amputácia.

Výsledky nášho výskumu naznačujú, že k stratégiám, ktoré pozitívne vplyvajú na efektívne zvládanie záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny, patrí Preventívne zvládanie situácií, Ne/vyhýbanie sa riešeniu situácií

a Strategické plánovanie. Preventívne zvládanie znamená anticipovanie potenciálnych stresorov a ich zvládnutie ešte pred tým, ako sa tieto stresory naplno prejaví. Strategické plánovanie znamená, že človek sa zameriava na vytváranie čiastkových, zvládnuteľných cieľov a je zameraný na ich dosahovanie. Obe tieto stratégie môžeme charakterizovať ako stratégie zamerané na riešenie problému [17]. Vyhýbanie sa riešeniu situácie znamená vyhýbanie sa aktivitám v situáciách, ktoré si vyžadujú riešenie. Naše výsledky sú plne v súlade s výskumami Desmonda [21, 22], podľa ktorého stratégie zamerané na vyhýbanie sú u pacientov s amputáciami v negatívnom vzťahu k psychologickej adaptácii a stratégie riešenia problému sú v pozitívnom vzťahu s optimálnou psychologickou adaptáciou. Ďalej uvádza, že vyhľadávanie sociálnej opory nemá vzťah k lepšej psychologickej adaptácii. Aj dané tvrdenie podporuje zistenie nášho výskumu, nakoľko stratégie vyhľadávanie inštrumentálnej opory a vyhľadávanie emočnej opory nepredikovali efektívne zvládanie záťaže u pacientov s amputáciou dolnej končatiny.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že ak pacient ešte pred amputáciou využíva stratégie riešenia problému, dokáže prijať amputáciu aj s jej dôsledkami a strategicky naďalej plánovať svoje ciele napriek obmedzeniam, má teda perspektívu efektívneho zvládania záťaže. Sú známe aj zistenia, že tí pacienti, ktorí majú fantómové bolesti po amputácii, majú tendenciu vnímať svoje telo ako kompletne a nepoškodené. Naopak tí, ktorí sa lepšie vyrovnali so stratou končatiny, menej trpia fantómovými bolesťami [25].

Nevyhýbavé stratégie (stratégie zamerané na riešenie problému), ktoré sa ukazujú v našom výskume ako predikujúce efektívne zvládanie záťaže pacientov s amputáciou, sú v súlade s výsledkami iných výskumov [21, 22, 26]. Metaanalýza [26] uvádza, že nevyhýbavé stratégie sú spojené s pozitívnou adaptáciou pri väčšom časovom odstupe od pôsobenia stresora. Vyhýbavé stratégie sú efektívnejšie, ak hodnotíme zvládanie záťaže v kratšom časovom odstupe od pôsobenia stresora. V našom výskume sa môže hodnotenie zvládania záťaže (do 7 dní) javiť ako hodnotenie v krátkom časovom odstupe. Samotná amputácia však pre pacientov neznamena začiatok riešenia situácie, nakoľko sa na ňu mohli začať pripravovať už skôr. Aj preto považujeme nevyhýbavé stratégie za efektívne aj u pacientov s plánovanou amputáciou v dôsledku chronického ochorenia.

Za limity výskumu považujeme veľkosť súboru, vekové zloženie vzorky (prevažne starší pacienti), ako aj rôzne typy či indikácie amputácií dolnej končatiny. Napriek uvedeným limitom môžeme konštatovať, že efektívnejšie zvládanie situácie amputácie dolnej končatiny môžeme vnímať ako lepšie psychologické fungovanie a práve niektoré stratégie proaktívneho zvládania k nemu prispievajú.

Záver

Pacienti s amputáciou dolnej končatiny nepreukazujú výrazne neefektívne ani výrazne efektívne zvládanie záťaže. Významné prediktory zvládania záťaže v tejto skupine pacientov predstavujú stratégie: Preventívne zvládanie,

Strategické plánovanie, Ne/vyhybanie sa riešeniu situácie, ktoré efektívnosť zvládania záťaže pacientov s amputáciou zvyšujú. Vek a pohlavie neovplyvňujú efektívnosť zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny. Výsledky výskumu sú prínosné pre sestru v procese rozhodovania o starostlivosti pacienta s amputáciou dolnej končatiny, pri formulácii ošetrovateľskej diagnózy Neefektívne zvládanie záťaže, najmä však pri predpovedaní vývoja tejto diagnózy. Znalosť bežnej stratégie zvládania záťaže pacientov môže byť pre sestru prínosná, nakoľko ide o hlavný prediktor toho, ako bude pacient zvládať amputáciu.

Konflikt záujmov

Autori prehlasujú, že si nie sú vedomí žiadneho konfliktu záujmu týkajúceho sa uvedeného príspevku.

Pod'akovanie

Príspevok bol podporený grantovou agentúrou APVV (Grant číslo APVV-0532-10 „Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládanie záťaže v ošetrovateľstve“) a UGA UKF v Nitre (VIII/13/2012 Psycho-sociálne potreby chorého v kontexte ošetrovateľstva).

LITERATÚRA

- [1] Kebza V. Zvládání stresu. Praha: Státní zdravotní ústav; 1997.
- [2] Křivohlavý J. Psychologie zdraví. Praha: Portál; 2001.
- [3] Schreiber V. Stres. Praha: Avicenum; 1985.
- [4] Herdman TH (ed.). NANDA International. Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2012–2014. 9th ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
- [5] Ackley BJ, Ladwig GB. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care. 10th ed. Elsevier, Inc.; 2014.
- [6] Lazarus RS, Folkman S. Coping and adaptation. In: Gentry WD (Ed.). Handbook of behavioral medicine. New York: Springer; 1984, pp. 282–305.
- [7] Bratská M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca; 2001.
- [8] Schwarzer R, Taubert S. Tenacious goal pursuits and striving toward personal growth: Proactive coping. In: Frydenberg E (ed.). Beyond coping: Meeting goals, visions and challenges. London: Oxford University Press; 2002, pp. 19–35.
- [9] Greenglass ER. Proactive coping, work stress and burnout. J Int Stress Manage Assoc 2001;13:5–8.
- [10] Kobasa SC, Maddi SR, Puccetti MC, Zola MA. Effectiveness of hardiness exercise and social support as resources against illness. J Psychosom Res 1985;29:525–33.
- [11] Matthews KA. Coronary heart disease and type A behaviors: Update on and alternative to the Booth – Kewley and Friedman quantitative review. Psychol Bull 1988;104: 373–80.
- [12] Suls J, David JP, Harvey JH. Personality and coping: Three generations of research. J Pers 1996;64:711–35.
- [13] Keefe FJ, Williams DA. A comparison of coping strategies in chronic pain patients in different age groups. J Gerontol 1990;45(4):161–5.
- [14] Ruiselová Z. Štýly zvládania záťaže. In: Ruiselová Z a kol. Štýly zvládania záťaže a osobnosť. Bratislava: SAV; 2006, s. 9–20.
- [15] Moorhead S et al. Nursing Outcomes Classification (NOC). 4th ed. Mosby, Inc.; 2008.
- [16] Sollár T, Romanová, M. Proaktívne zvládania – koncept a súčasný stav merania. In: Sollárová E (ed.). Pomáhajúce profesie – aktuálne trendy v teórii, výskume a praxi. Sekcia 1. Záťaž a odolnosť v pomáhajúcich profesiách. Nitra: UKF; 2011, s. 103–30.
- [17] Livneh H, Antonak RF, Gerhardt J. Multidimensional Investigation of the Structure of Coping Among People with Amputations. Psychosomatics 2000;41:235–44.
- [18] Hampel P, Rudolph H, Stachow R, Lab-Lentzsch A, Petermann F. Coping among children and adolescents with chronic illness. Anxiety, Stress, and Coping 2005;18(2):145–55.
- [19] Cavanagh SR, Shin LM, Karamouz N, Rauch SL. Psychiatric and Emotional Sequelae of Surgical Amputation. Psychosomatics 2006;47:459–64.
- [20] Výrost J, Lovaš L, Baumgartner F, Bolfiková E, Frankovský M, Hadušovská S. Possibilities of empirical classifications of demanding life situations. Stud Psychol 1995;37:93–106.
- [21] Desmond DM. Coping, affective distress, and psychosocial adjustment among people with traumatic upper limb amputations. J Psychosom Res 2007;62:15–21.
- [22] Desmond DM, MacLachlan M. Coping strategies as predictors of psychosocial adaptation in a sample of elderly veterans with acquired lower limb amputations. Social Sci Med 2006;62:208–16.
- [23] Greenglass ER, Marques S, deRidder M, Behl S. Positive coping and mastery in a rehabilitation setting. Int J Rehabil Res 2006;28(4):331–9.
- [24] Greenglass ER, Fiksenbaum L. Proactive Coping, Positive Affect, and Well-Being Testing for Mediation Using Path Analysis. Eur Psychol 2009;14(1):29–39.
- [25] Pucher I, Kicking W, Frischenschlager O. Coping With Amputation and Phantom Limb Pain. J Psychosom Res 1999;46(4):379–83.
- [26] Suls J, Fletcher B. The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping strategies: A meta-analysis. Health Psychol 1985;4(3):249–88.